

## Insuficiência cardíaca · congestão e perfusão

Na IC aguda descompensada, classifique congestão (úmido/seco) e perfusão (quente/frio). A conduta de prova segue o perfil hemodinâmico, não só a FE.

### Sinais de congestão e hipoperfusão

#### Lembre - Sinais de congestão e hipoperfusão

Congestão: ortopneia, crepitações, edemas, turgência jugular, B3. Hipoperfusão: extremidades frias, oligúria, confusão, lactato! , PAM baixa ou pulso fino.

*Úmido-quente é o mais comum; úmido-frio exige vasoativo/inotropo e cuidado com hipotensão.*

### Perfis de IC aguda

Congestao x perfusao (Forrester clinico)

#### Umido-quente

Congestao + perfusao OK  
Diuretico +/- vasodilatador  
O2 / VNI se EAP

**Perfil mais frequente**

#### Umido-frio

Congestao + hipoperfusao  
Inotropo / vasopressor  
UTI / suporte avancado

**Choque cardiogenico**

#### Seco-frio

Baixo debito sem edema  
Volume prudente se hipovolemico  
Inotropo se persistir

**Menos comum**

### Conduta inicial

- ABC, O<sub>2</sub> / VNI (CPAP/BiPAP) no EAP hipertensivo se sem contraindicação
- Diurético de alça EV na congestão (furosemida); monitorar diurese e K<sup>+</sup>
- Vasodilatador (nitrato) se PA elevada e congestão — evitar se hipotenso
- Troponina, ECG, Rx tórax, BNP/NT-proBNP e etiologia precipitante (IAM, infecção, FA, falha de adesão)

### Drogas por cenário

#### Cenário | Preferência de prova

EAP + HAS | VNI + nitrato + diurético

Congestão, PA estável | Diurético ± vasodilatador

Choque cardiogênico | Noradrenalina ± dobutamina; UTI

IC crônica estável (alta) | IECA/BRA/ARNI + beta-bloqueador + antialdosterônico + iSGLT2

### Armadilha de prova

#### Atencao - Armadilha de prova

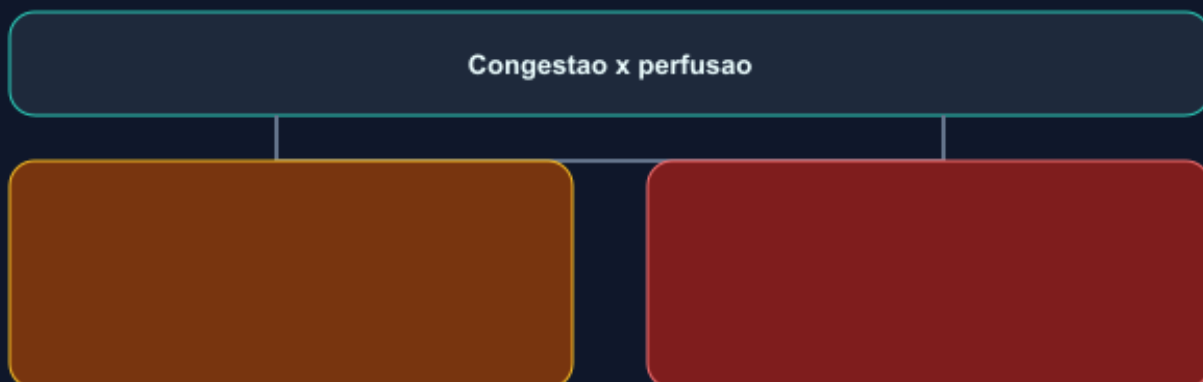
Não inicie ou aumente beta-bloqueador na descompensação com congestão/hipoperfusão franca. Mantenha dose se já em uso e estável; suspenda se choque ou BAV grave.

### Para a prova — escalas e macetes

#### Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Perfis Forrester (congestão × perfusão) e NYHA organizam o manejo da insuficiência cardíaca aguda e crônica.

## Forrester / perfis clínicos



Classificação funcional clássica; não é etiologia nem FE.

## NYHA

Limitacao funcional

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| I - sem limitacao                   | I   |
| II - leve aos esforcos habituais    | II  |
| III - marcada aos pequenos esforcos | III |
| IV - sintoma em repouso             | IV  |

I assintomatico | IV sintoma em repouso

## Conduta por perfil (ideia)

### Perfil | Ênfase

Quente-úmido | Diurético de alça ± vasodilatador se PA ok

Frio-úmido | Inotrópico / vasopressor + descongestão; UTI

Frio-seco | Volume criterioso se hipovolemia; investigar baixo débito

Quente-seco | Otimizar terapia oral da IC

### Terapia modificadora (FE reduzida) — prova

- IECA/BRA/ARNI
- Betabloqueador evidência (carvedilol, bisoprolol, metoprolol succ.)
- Antagonista mineralocorticoide (espironolactona/eplerenona)
- iSGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina)
- Diurético para sintoma/congestão (não reduz mortalidade sozinho)

## **BNP/NT-proBNP**

### **Lembre - BNP/NT-proBNP**

Úteis para exclusão/diagnóstico diferencial de dispneia; elevam-se na IC, mas sobem também em IRA, idade avançada, TEP, sepse.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.  
[www.medhubr1.com.br](http://www.medhubr1.com.br) - MedHub R1